原因不明な血球貪食症候群の 1 剖検例

◎角谷 茉里恵[1)]、山本 雄一[1)]、丸井 理恵子[1)]、林 豊[1)]、福本 義輝[1)]
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 松阪総合病院[1)]

【はじめに】血球貪食症候群（以下 HPS）とは活性化マクロファージによる血球の貪食を特徴とし、高熱、血球減少、凝固異常、肝障害等の症状を呈し、しばしば致死的な経過をたどる。今回我々は、臨床的にリンパ腫関連血球貪食症候群（LAHS）が疑われたものの、病理解剖においても HPS 発症の原因疾患の特定に至らなかった 1 例を経験したので報告する。

【症例】74 歳・男性。発熱持続し ADL が低下したため当院 ER を受診。熱源精査にて入院となった。フェリチン 45759.2 ng/mL、sIL2R 39786 U/mL と高値を示し、血小板 $3\times10^4/\mu L$ と低値を認めた。血球貪食症候群の診断基準 5/8 項目を満たした。EBV、CMV、HIV、HTLV1、膠原病に対する抗体検査結果からは血球貪食症候群の原因は特定できなかった。画像所見から著明な肝脾腫を認めたが、明らかなリンパ節腫脹を認めなかったため、血管内リンパ腫が鑑別疾患に挙げられた。診断目的にランダム皮膚生検が施行されたが、リンパ腫細胞は検出できなかった。後にステロイド療法が施行されたが永眠され、死因特定の目的で病理解剖が行われた。

【解剖組織所見】病理解剖において骨髄、肝、脾で CD68 陽性の貪食像を認めた。一方、皮膚を含め、各臓器でリンパ腫細胞は認めなかった。また EBER-ISH などから感染症の所見も得られなかった。腎臓の間質に尿細管壊死、糸球体にフィブリン血栓が認められ、急性腎障害と診断された。

【考察】本症例では血球貪食像が一部で認められた。しかし HPS に特異的な所見ではないことや、何視野に何個、血球貪食像があれば該当するといった定量的な診断基準もないことから病理所見のみで HPS を診断するのは困難であり、臨床の判断基準と病理所見での総合評価が重要であると考えられた。病理解剖を含めた精査においても原因疾患の特定には至らなかったことから感染症を含む何らかの疾患に伴う HPS の可能性が示唆された。発熱及び臓器不全に関しては、免疫系の過剰な活性化による炎症性サイトカインが制御不能に放出され、サイトカインストームが引き起こされたと考えられた。

内線 272